

الإحليل الحلقي هو طريقة لصرف البول بعد استئصال المثانة أو توقفها عن العمل. يستخدم الجراح قطعة قصيرة من الأمعاء الدقيقة لنقل البول من الكليتين إلى فتحة صغيرة في البطن (الفغرة)، تصرف البول إلى كيس خفيف ترتديه. وهو أبسط التحويلات البولية وأكثرها شيوعاً.

عن هذه العملية

تُستخدم قطعة من الأمعاء الدقيقة بطول 15–20 سم كممر للبول — لا تخزّنه. تُوصَل الحالبات (الأنابيب من الكليتين) بها، ويُخرج أحد طرفيها عبر جدار البطن كفغرة، عادةً في أسفل البطن الأيمن. لأن البول يصرف باستمرار، ترتدي كيساً خفيفاً (كيس الفغرة) فوقها تُفرّغه عدة مرات يومياً وتُبدّله كل بضعة أيام.

- لا حاجة إلى تحكّم أو قسطرة.
- تُعاد وصلة بقية الأمعاء فيستمر الهضم بصورة طبيعية.
- ممرضة الفغرة تتعلّم العناية بها وبالكيس.

هل هو آمن؟

الإحليل الحلقي هو المعيار المعتمد للتحويل البولي منذ أكثر من 70 عاماً — أبسط الخيارات وأقصرها زمناً. كأي جراحة كبرى يحمل مخاطر (نزيف، عدوى، تسرّب عند مواضع التوصيل). مع الوقت قد تظهر مشكلات جلدية حول الفغرة، أو عدوى بولية، أو تغييرات في الأملاح والفيتامينات — يُراقب عليها في المتابعة الدورية.

تعلّم المصطلحات

التحويل البولي

مسار جديد لخروج البول عند غياب المثانة أو توقفها عن العمل.

الإحليل الحلقي

قطعة قصيرة من الأمعاء الدقيقة تنقل البول إلى الفغرة.

الفغرة (Stoma)

الفتحة الصغيرة في البطن المصنوعة من الأمعاء، التي يخرج منها البول.

كيس الفغرة

الكيس (الجهاز) الذي يُرتدى فوق الفغرة لتجميع البول.

الحالبات

الأنابيب التي تنقل البول من الكليتين وتُوصَل بالقناة.

ممرضة الفغرة

ممرضة تحدّد موضع الفغرة وتعلّم العناية بها وبالكيس.

المخاط

سائل تنتجه الأمعاء؛ خيوطه في البول أمر طبيعي.

الجلد المحيط بالفغرة

الجلد حول الفغرة الذي يُحافظ على نظافته وحمايته.

هل سيؤلم؟ تُجرى الجراحة تحت التخدير العام فلا تشعر بشيء خلالها. بعدها توقع ألماً في البطن، وتأخذ الأمعاء بضعة أيام لـ"الاستيقاظ" (تبدأ بالسوائل ثم تتدرج). الفقرة نفسها لا تؤلم. يمكث معظم المرضى في المستشفى نحو 5-7 أيام.

كيف تستعدّ (قبل الجراحة)

بعد الجراحة

- تعود إلى المنزل في نحو 5-7 أيام. تعلّمك ممرضة الفقرة تفريغ الكيس (عدة مرات يومياً) وتبديل الكيس (كل بضعة أيام).
- خيوط المخاط في البول طبيعية — تنتجها الأمعاء.
- اشرب كميات وفيرة من السوائل وعانِ الجلد حول الفقرة.
- تجنّب رفع الأثقال لمدة 6 أسابيع. ستحتاج إلى متابعة مدى الحياة (وظائف الكلى، فيتامين B12).

- تُجرى تحت التخدير العام — اتّبِع جميع تعليمات الجراحة (الصيام، وأي أدوية يجب إيقافها بما فيها مميّعات الدم). قد تحتاج إلى تحضير الأمعاء.
- قابل ممرضة الفقرة التي تحدّد أفضل موضع للفقرة وأنت جالس وواقف ومستلقٍ — هذا ضروري لضمان كيس مريح ومانع للتسرّب.
- أقلع عن التدخين — فهو يُبطئ الشفاء — ورثب مساعدة في المنزل بعد الجراحة.

أخبر فريقك مسبقاً إذا كنت:

- تتناول ممّيع دم، أو لديك عدوى حالية
- تعاني من مرض في الأمعاء (كمرض كرون أو التهاب القولون) أو سبق لك إجراء جراحة بطنية أو علاج إشعاعي

ما الذي يحدث أثناء الجراحة

اتصل بفريقك الطبي أو اطلب الرعاية إذا كان لديك:

- حمّى أو قشعريرة
- الفقرة تتحوّل داكنة أو زرقاء أو تنسحب للداخل
- بول قليل أو معدوم في الكيس لعدة ساعات
- ألم شديد في البطن، أو قيء، أو انعدام الغازات أو البراز (توقف الأمعاء)
- نزيف غزير، أو احمرار الجرح أو إفرازاته

- 1 أنت نائم تحت التخدير وتُعطى المضادات الحيوية.
- 2 تُعزّل قطعة قصيرة من الأمعاء وتُوصّل بقية الأمعاء ببعضها.
- 3 تُوصّل الحالبات بقطعة الأمعاء.
- 4 يُخزج الطرف الآخر عبر جدار البطن كفقرة، وتوضع جبائر ناعمة ومصرف أثناء الشفاء.

ثلاثة أمور تذكّرها

1. يستخدم الإحليل الحلقى قطعة قصيرة من الأمعاء لصرف البول إلى فقرة في البطن داخل كيس — أبسط التحويلات ولا يتطلب قسطرة.
2. للتحضير: اتّبِع تعليمات الصيام وتحضير الأمعاء، والتقى بممرضة الفقرة لتحديد موضعها، وأقلع عن التدخين، ورثب مساعدة في المنزل.
3. المخاط في البول طبيعي، وستعلّمك ممرضة الفقرة العناية بالكيس والجلد. اتصل فوراً عند وجود حمّى، أو تغيير لون الفقرة، أو نقص البول في الكيس، أو توقف الأمعاء عن العمل.